Prevención de endocarditis infecciosa en pediatría

Resumen de recomendaciones basado en las guías AHA (2007, actualización 2021), AHA en endocarditis pediátrica (2015) y ESC 2023

1. Quiénes requieren profilaxis (pacientes pediátricos de mayor riesgo)

Criterio AHA: la profilaxis es razonable solo en las siguientes condiciones cardiacas:

Categoría	Condición
Material protésico	Válvula cardíaca protésica (incluye válvulas transcatéter y homoinjertos) o material protésico usado en reparación valvular (anillos de anuloplastia, cuerdas).
Endocarditis previa	Antecedente de endocarditis infecciosa.
Cardiopatía congénita (CC)	• CC cianótica **no reparada**, incluidos shunts y conductos paliativos. • CC **completamente reparada con material protésico o dispositivo** (quirúrgico o por catéter), durante los **primeros 6 meses** posteriores al procedimiento (hasta la endotelización). • CC reparada con **defectos residuales** en el sitio o adyacentes a un parche o dispositivo protésico (inhiben la endotelización).
Trasplante cardiaco	Receptores de trasplante cardiaco que desarrollan valvulopatía.

ESC 2023: mantiene como alto riesgo la endocarditis previa, las prótesis valvulares (quirúrgicas y transcatéter, o con cualquier material en reparación), la CC cianótica no tratada y la CC tratada con defectos residuales (shunt o regurgitación) en el sitio del parche o dispositivo; para CC reparada con material protésico, la profilaxis se indica durante los primeros 6 meses. Se debe *considerar* en reparación transcatéter mitral/tricuspídea y *puede considerarse* en receptores de trasplante cardiaco.

2. En qué procedimientos

Se recomienda (solo en pacientes de alto riesgo)	No se recomienda
• Extracciones dentales • Procedimientos que manipulan el tejido gingival o la región periapical del diente • Procedimientos que perforan la mucosa oral • Cirugía oral y limpieza dental con sangrado esperable • Procedimientos invasivos del tracto respiratorio con incisión o biopsia de la mucosa (p. ej., amigdalectomía, adenoidectomía, broncoscopia con biopsia) • Infección de piel, tejidos blandos o músculo-esquelética: tratar con un agente activo contra estafilococos y estreptococos beta-hemolíticos	• Radiografías dentales • Anestesia local en tejido no infectado • Colocación o ajuste de aparatos ortodónticos o prótesis removibles, brackets • Caída de piezas deciduas • Sangrado por trauma de labios o mucosa oral • Procedimientos gastrointestinales o genitourinarios, solo con fin de prevenir endocarditis • Cateterismo cardiaco diagnóstico (no figura entre los procedimientos con indicación de profilaxis por endocarditis)

Si hay infección del tracto GI/GU en un paciente de alto riesgo, el tratamiento debe incluir cobertura para enterococo. La profilaxis perioperatoria en cirugía cardiaca o con material protésico sigue los protocolos quirúrgicos propios y no es el tema de esta hoja.

3. Esquemas antibióticos pediátricos (dosis única, 30–60 min antes del procedimiento)

Situación	Fármaco	Dosis pediátrica	Máximo
Puede tomar vía oral	**Amoxicilina**	50 mg/kg v.o.	2 g
No puede tomar vía oral	Ampicilina o Cefazolina / Ceftriaxona	50 mg/kg i.m. o i.v. 50 mg/kg i.m. o i.v.	2 g 1 g
Alergia a penicilinas – vía oral	Cefalexina* o Azitromicina / Claritromicina o Doxiciclina	50 mg/kg v.o. 15 mg/kg v.o. <45 kg: 2,2 mg/kg v.o. 45 kg o más: 100 mg v.o.	2 g 500 mg 100 mg
Alergia a penicilinas y sin vía oral†	Cefazolina o Ceftriaxona	50 mg/kg i.m. o i.v.	1 g

- * U otra cefalosporina oral de primera o segunda generación en dosis equivalente. † No usar cefalosporinas si hubo anafilaxia, angioedema o urticaria con penicilinas/ampicilina.
- La dosis calculada en niños **no debe superar la dosis de adulto**. Pesar al niño para dosificar.
- **Clindamicina:** ya no se recomienda como profilaxis dental (AHA 2021), por riesgo de colitis por *C. difficile* y sin evidencia de ventaja.
- Doxiciclina: no recomendada en menores de 8 años (hasta esa edad, elegir cefalexina o azitromicina/claritromicina).
- Si no se administró antes del procedimiento, puede darse hasta 2 h después.
- Si el paciente ya recibe un antibiótico (p. ej., penicilina para profilaxis secundaria de fiebre reumática), elegir un fármaco de **otra clase**.

Las dosis deben verificarse siempre contra la fuente primaria y las pautas institucionales antes de prescribir.

4. Medidas generales de prevención (todos los niños con cardiopatía)

- **Higiene bucal:** cepillado al menos 2 veces al día y uso de hilo dental según edad; tratar caries y gingivitis de forma temprana.
- **Control odontológico regular:** en pacientes de alto riesgo, idealmente cada 6 meses, y establecer el primer control a edad temprana (primer año de vida o al erupcionar los primeros dientes). Coordinar con el odontopediatra, informando la condición cardiaca y el esquema indicado.
- **Piel y mucosas:** evitar piercings y tatuajes; tratar infecciones cutáneas de forma oportuna.
- **Antibióticos:** evitar la autoprescripción; **tomar hemocultivos antes de iniciar antibióticos** ante fiebre sin foco en un niño de riesgo.
- **Accesos vasculares:** mínima permanencia de líneas centrales y estricta técnica aséptica.
- **Educación a familia y paciente:** reconocer síntomas de alarma (fiebre persistente, decaimiento, sudoración nocturna, manifestaciones cutáneas) y consultar de inmediato. Entregar un **carnet o certificado** con el diagnóstico cardiaco, la indicación de profilaxis y el esquema antibiótico.

5. Resumen comparativo de guías

	AHA 2007 / 2021	ESC 2023
Enfoque	Riesgo de resultado adverso de la endocarditis, no de contraerla.	Prevención con higiene para todos; profilaxis en alto riesgo.
Procedimientos	Dentales con manipulación gingival/periapical o perforación de mucosa; algunos respiratorios con biopsia/incisión.	Dentales (gingival/periapical o perforación de mucosa); contempla procedimientos invasivos no dentales en alto riesgo.
CC	Cianótica no reparada; reparada con material protésico en los primeros 6 meses; defectos residuales.	Cianótica no tratada; reparada con defectos residuales; con material protésico durante 6 meses.
Clindamicina	No recomendada (2021).	—

Referencias

- Wilson WR, Gewitz M, Lockhart PB, et al. Prevention of Viridans Group Streptococcal Infective Endocarditis: A Scientific Statement From the American Heart Association. *Circulation*. 2021;143(20):e963–e978. doi:10.1161/CIR.0000000000000969
- Wilson W, Taubert KA, Gewitz M, et al. Prevention of Infective Endocarditis: Guidelines From the American Heart Association. *Circulation*. 2007;116:1736–1754.
- Baltimore RS, Gewitz M, Baddour LM, et al. Infective Endocarditis in Childhood: 2015 Update. A Scientific Statement From the American Heart Association. *Circulation*. 2015;132:1487–1515.
- Delgado V, Ajmone Marsan N, de Waha S, et al. 2023 ESC Guidelines for the management of endocarditis. *Eur Heart J*. 2023;44(39):3948–4042.

Material de consulta rápida para profesionales de la salud. No reemplaza el juicio clínico ni las guías locales; contrastar con los consensos vigentes de las sociedades científicas argentinas y verificar las dosis antes de prescribir.